1. IDENTIFICACIÓN Y ANTROPOMETRÍA

Nombre	Documento	Teléfono
Paciente Ejemplo	CC 000000	3000000000

Edad	Sexo	Peso	Talla	IMC
64 años	Femenino	102 kg	162 cm	38.9 kg/m2

Superficie corporal	Perímetro abdominal	Presión arterial	Frecuencia cardíaca	SpO2
2.05 m2	118 cm	142/88 mmHg	78 lpm	95 %

2. ENCUESTA CLÍNICA

Clase funcional	NYHA II · 8 meses de evolución
Síntomas	edema de miembros inferiores
Antecedentes	HTA, diabetes
Tratamiento	Antihipertensivos: 2 · diurético: sí
Exploración	Sin signos congestivos

3. ECOCARDIOSCOPIA DIRIGIDA

VENTRÍCULO IZQUIERDO

FEVI	SIV diástole	Pared posterior	DTDVI
60 %	12 mm	11.5 mm	48 mm

Masa VI	Índice de masa VI	Grosor parietal relativo
213 g	104 g/m2	0.48

FUNCIÓN DIASTÓLICA

Onda E	Onda A	E/A	e' septal
95 cm/s	70 cm/s	1.36	6 cm/s

e' lateral	E/e' promedio	Volumen AI	VAI indexado
8 cm/s	13.6	78 mL	38 mL/m2

PRESIONES PULMONARES Y CAVIDADES DERECHAS

Velocidad máx. IT	VCI	Colapso VCI	PAD estimada
3.0 m/s	22 mm	< 50 %	15 mmHg

PSAP estimada	TAPSE	VD basal
51 mmHg	21 mm	38 mm

Observaciones Ventana subóptima por hábito corporal; mediciones en apical.

4. PUNTAJES DE PROBABILIDAD

H2FPEF (REDDY 2018)

6 / 9

Alta probabilidad · ~90 %

IMC 2 · HTA 1 · FA 0 · PSAP 1 · Edad 1 · E/e' 1

HFA-PEFF · DOMINIO ECO

4 / 4

4 puntos: compatible con ICFEp aun sin biomarcador

Funcional: mayor (2) · Morfológico: mayor (2) · sin NT-proBNP

5. CONCLUSIÓN Y CONDUCTA

Alta probabilidad de ICFEp

Remitir a consulta de cardiología / clínica de falla cardíaca. Solicitar NT-proBNP, ecocardiograma completo, ECG de 12 derivaciones y laboratorios (creatinina, HbA1c, perfil lipídico, ferritina). Evaluar candidatura a agonista GLP-1 / iSGLT2 según el especialista.

CONDUCTA

NT-proBNP + ecocardiograma completo ambulatorio

Dr. Juan Fernando Carvajal
Firma y registro médico